

이 시술은 방광경부, 즉 전립선 수술 후 방광과 요도를 다시 연결한 부위에 생긴 좁은 흉터 조직을 내시경만으로 교정합니다 — 외부 절개가 없습니다. 집도의가 흉터 조직을 절개해 통로를 열고, 건강한 방광 점막을 봉합하여 흉터 조직이 다시 막히지 않고 열린 채로 회복되도록 합니다.

이 시술에 대하여

전립선 수술이나 방사선 치료 후 방광경부 또는 방광-요도 문합부에 좁은 흉터 조직이 생겨 소변 흐름을 막을 수 있습니다. 흉터 조직을 단순히 절개만 하면 노출된 흉터 조직 위로 다시 유착되는 경우가 많습니다.

이 기법 — TUITMR (경요도 절개 후 횡방향 점막 재배열) — 은 이 문제를 해결합니다:

- 집도의가 내시경을 통해 **흉터 조직을 절개**하여 통로를 엽니다.
- 특수 **봉합 도구**를 이용해 건강한 방광 점막을 절개 부위 위로 당겨 봉합합니다 — 요도 안에서 시행하는 피판 교정과 유사합니다.

초기 결과는 고무적입니다. 첫 보고 환자군에서 **약 10명 중 9명**이 1회 시술 후 통로가 유지되었고, 2회 후에는 거의 전원에서 유지되었으며 새로운 요실금 위험도 낮았습니다.

안전한가요?

시술 전체가 요도를 통해 이루어지므로, 이 부위에 사용되는 더 큰 로봇 수술이나 개복 수술을 피할 수 있습니다. 초기 근거에 따르면 새로운 요실금 위험이 낮은 편이며, 이는 다른 교정술에서 합병증으로 나타날 수 있습니다. 위험으로는 출혈, 요로감염(UTI), 협착 재발이 있습니다. 비교적 새로운 전문 기법입니다.

용어 설명

방광경부

방광이 요도로 이어지는 출구 부위.

방광경부 구축

방광경부에 생긴 좁은 흉터로 소변 흐름을 막음.

문합부 협착

전립선 수술 후 방광과 요도를 연결한 부위에 생긴 좁아짐.

요도

소변이 몸 밖으로 나오는 관.

점막(내벽)

흉터를 덮어 열린 채로 회복되도록 봉합하는 건강한 내벽 조직.

방광경(내시경)

집도의가 사용하는 가는 카메라 기구.

요실금

소변이 새는 것 — 이 기법으로 최소화하려는 위험.

도뇨관

회복 중 요도에 잠시 유치하는 부드러운 관.

아프나요? 시술은 마취 하에 진행되므로 시술 중에는 아무것도 느끼지 않습니다. 이후 며칠간 약한 작열감과 약간의 혈뇨가 있을 수 있습니다. 도뇨관이 잠시 유치됩니다. 대부분 당일 또는 짧은 입원 후 귀가합니다.

준비 방법 (시술 전)

- **전신마취**로 진행됩니다 — 금식 및 복용 약물(혈액희석제 포함) 중단에 관한 모든 지시를 따르세요.
- **소변 검사**로 감염 여부를 확인합니다 — 감염이 있으면 먼저 치료해야 합니다.
- 시술 후 **도뇨관을 잠시 유치**할 것을 대비하고, 귀가 시 동행자를 미리 준비하세요.

다음 사항은 **미리 의료진에게 알려주세요**:

- **혈액희석제**를 복용 중이거나, 현재 **요로감염**이 있는 경우
- **전립선 수술, 방사선 치료** 또는 이 부위의 이전 치료 이력이 있는 경우

시술 과정

- 1 마취 후 항생제를 투여합니다.
- 2 내시경을 흉터 조직 부위까지 진입시키고 안전을 위해 가이드와이어를 삽입합니다.
- 3 흉터 조직을 확장하고 절개하여 통로를 엽니다.
- 4 요도를 통해 봉합 도구를 삽입해 건강한 방광 점막을 절개 부위 위로 봉합한 후, 도뇨관을 유치합니다.

후

- **당일 또는 짧은 입원 후 귀가**하며, 도뇨관을 잠시 유치합니다.
- 며칠간 **약한 작열감과 분홍빛 소변**이 있을 수 있습니다. 물을 충분히 마시면 도움이 됩니다.
- 몇 주간 **무거운 물건 들기 및 힘주기를 삼가**세요.
- 약 **4개월 후** 추적 내시경 검사로 통로가 열려 있는지 확인합니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한
- 도뇨관 제거 후 **소변을 볼 수 없는 경우**
- 새로운 심한 **요실금**
- 심한 출혈, 혈전, 또는 통증 악화

기억할 세 가지

1. 이 시술은 방광경부 흉터를 절개 없이 교정합니다 — 흉터를 열고 건강한 점막으로 덮어 열린 채로 회복되며, 새로운 요실금 위험이 낮습니다.
2. 준비: 금식 및 약물 지침을 따르고, 감염을 먼저 치료하며, 도뇨관 유치와 귀가 동행자를 미리 준비하세요.
3. 며칠간의 약한 작열감과 분홍빛 소변은 정상입니다. 추적 내시경으로 성공 여부를 확인합니다. 발열, 소변 불가, 새로운 심한 요실금, 심한 출혈이 있으면 즉시 연락하세요.